Informe de Consultoría Preliminar GDP I

Equipo consultor: PRISMA
Empresa: Asch
Ayudante: Francisca Valencia

Descripción de la organización

La asociación chilena de la seguridad, Achs a partir de ahora, se funda en el año 1958, aunque es en 1968 bajo la ley 16.744 se implementa el seguro obligatorio, donde se reconocía a la Achs como uno de los prestadores de este seguro, es en este contexto donde se asienta la misión de la Achs: "proteger y cuidar a las personas en sus lugares de trabajo, previniendo accidentes laborales y enfermedades profesionales" (Achs, s.f.) demostrando su compromiso con sus asociados tanto en la prevención de riesgos como en el cuidado cuando el siniestro ya ocurrió.

Actualmente la Achs posee alrededor de un 52% de participación del mercado, convirtiéndola en la firma más importante del rubro, aparte de contar con más de 90.000 entidades afiliadas, lo que se traduce en más de 3 millones de trabajadores asegurados en los más de 80 centros de salud que se distribuyen por todo Chile.

Parte esencial y característica de la Achs es su cultura organizacional que posee 4 pilares:

- Cultura centrada en las personas: Donde poseen equipos multidisciplinarios enfocados en los usuarios.
- Generar un impacto positivo: Considerando siempre el entorno social, que la mayoría del tiempo suele ser un desafío para la empresa.
- Vanguardia en la innovación: Donde se enfocan tanto en la eficiencia operativa, como en la calidad de sus implementos en el área de la salud.
- Oportunidad de crecimiento: Para los empleados, ofreciendo multiples opciones de formación y reclutamiento interno, para fomentar el desarrollo interno y mantener a los profesionales formados.

Es a través de estos 4 pilares que la Achs mantiene una cultura organizacional que la impulsa a crecer y a mantener su prestigio, donde se enfoca tanto en el desarrollo interno de la empresa a niveles operativos, como también en mantener la mejor calidad en el trato con los clientes.

La Achs se relaciona con sus clientes en una primera instancia a través de un colaborador o un departamento que esté a cargo, donde la asociación le entrega este seguro (B2B), aunque esta también presta servicios particulares a asesoras del hogar o similares (B2C), es en esta fase previa donde también se trabaja en conjunto para prevenir accidentes en los distintos espacios. Al momento de presentarse una catástrofe la Achs trabaja directamente con los afectados tratándolos en sus distintos centros y derivándolos si es necesario. Así también esta trata a pacientes en los horarios excedentes ofreciendo este servicio al público general.

Como se mencionaba anteriormente la Achs cuenta con una presencia integral a lo largo de todo el territorio nacional. Debido a este alcance, la institución no es ajena a las problemáticas que afectan al sistema de salud chileno; entre ellas, la complejidad de reclutar médicos dispuestos a radicarse en zonas extremas. Sin embargo, la ventaja que poseen las

entidades estatales es que estas ofrecen bonos que llegan a duplicar el sueldo del trabajador, mientras que para la Achs resulta más complejo dado que es una organización sin fines de lucro. A esto se le suma que la Achs queda en un intermedio donde esta no es una entidad estatal, por lo que no ofrece los mismos beneficios que trabajar para el Estado, pero tampoco es una entidad privada con fines de lucro, por lo que tampoco tiene las ventajas del sistema privado, esto provoca que la Achs queda ubicada en un punto que en una primera instancia de análisis puede ser poco atractivo para los médicos.

Esto genera un malestar en la organización tanto en niveles operativos, ya que existe una falta de personal que no permite el funcionamiento idóneo de los centros afectados, como también a niveles de entorno social, puesto que en zonas extremas se estaría perdiendo la capacidad de atender a personas en el área de la salud, provocando un pesar en las comunidades donde no existen tantos proveedores del área y en consecuencia afectando la imagen de la Achs en términos generales.

Análisis de funciones y prácticas de gestión de personas

Estructura y posicionamiento de la gestión de personas

La Achs presenta una estructura organizacional robusta, compuesta por 5 gerencias divisionales: Prevención y desarrollo comercial, Operaciones de salud, Finanzas, Administración e infraestructura, Control de gestión y cumplimiento, y la División de personas y transformación organizacional. Esta última cumple un rol fundamentalmente estratégico: su influencia en la alta gerencia se manifiesta al actuar como un socio clave de la División de operaciones de salud. La gerencia División de personas y transformación organizacional, influye en la toma de decisiones de la alta dirección al proporcionar análisis de datos que permiten alinear la disponibilidad de staff médico con la continuidad operativa de los centros de salud, asegurando que el déficit de profesionales no comprometa la promesa de cuidado institucional**.** Al integrar la transformación digital, la división adquiere un poder de decisión relevante, permitiendo que los cambios tecnológicos y estructurales se realicen con una visión centrada en el colaborador.

Subsistemas de gestión de personas y composición del área

La gerencia de división de personas y transformación organizacional se organiza mediante una estructura jerárquica de "capas" que permite la especialización en distintos subsistemas de gestión de personas (Chiavenato, 2020):

- Liderazgo estratégico (Capa 1 y 2): Encabezada por una gerencia divisional, cuenta con una gerencia de cultura y talento y cuatro subgerencias: Desarrollo de talento y cultura, Gestión de personas, Relacionamiento estratégico y Relaciones laborales.
- Subsistemas operativos y tácticos (Capa 3 y 4): Se identifican funciones críticas distribuidas en jefaturas específicas:
    1. Atracción y marca empleadora / Reclutamiento y selección: Encargadas de la captación de talento.

2. Formación y talento: Foco en el desarrollo de competencias.
3. Bienestar y beneficios: Orientado a la propuesta de valor al empleado.
4. Comunicaciones internas y gestión del cambio: Eje articulador de la transformación cultural.
5. People analytics: Subsistema de soporte basado en datos para la toma de decisiones.

Identificación de la problemática en los subsistemas

Tras el diagnóstico preliminar y la información proporcionada por la contraparte, la problemática central de esta consultoría se refleja con mayor énfasis en el subsistema de atracción y marca empleadora, vinculado directamente con el desarrollo de talento y cultura.

A pesar de contar con una cultura organizacional reconocida, la Achs enfrenta el desafío crítico de fortalecer la atracción y fidelización de talento técnico/crítico. Esta brecha sugiere que, si bien los procesos de GP están estructurados, existe una necesidad de optimizar las estrategias de "engagement" y retención para asegurar que los perfiles clave permanezcan en la organización frente a un mercado laboral altamente competitivo y digitalizado. Asimismo, el subsistema de gestión del cambio se ve tensionado por la rapidez de la transformación digital, requiriendo un acompañamiento más efectivo para mitigar la resistencia y asegurar la adopción de nuevas capacidades (Robbins & Judge, 2017).

Fortalezas y desafíos del área de GP

El análisis de la unidad permite identificar un posicionamiento sólido con áreas de oportunidad claras:

- Fortalezas:
    1. Relevancia estratégica y articulación operativa: El área influye en la alta gerencia al demostrar que la gestión de médicos es un activo crítico para el negocio, logrando apoyo político para planes de incentivos y retención.
    2. Especialización en reclutamiento y marca empleadora: Contar con una jefatura dedicada exclusivamente a la atracción permite a la Achs posicionar su "propósito de cuidado" como un diferenciador competitivo para atraer médicos que buscan estabilidad y propósito, más allá de la oferta económica.
    3. Sinergia digital: La integración digital permite una agilidad superior para implementar plataformas de reclutamiento médico más rápidas y efectivas.
- Desafíos:
    1. Talento crítico: Es imperativo fortalecer las estrategias para atraer y, sobre todo, fidelizar a aquellos colaboradores con competencias escasas en el mercado, alineando la gestión al desarrollo de estas capacidades (Alles, 2016)

    2. Acompañamiento del cambio: Existe la necesidad de asegurar que los procesos de transformación organizacional sean asimilados de manera efectiva por

todos los niveles de la institución, minimizando la resistencia y optimizando la adopción de nuevas prácticas.

Definición del problema

Síntomas y Situaciones Puntuales

La problemática central se manifiesta en el incumplimiento crítico de los tiempos de respuesta internos para la dotación de médicos en agencias rurales y zonas extremas. Mientras que el estándar de servicio (SLA) para procesos de selección en la Región Metropolitana es de 24 días hábiles, el promedio en la zona Norte alcanza los 56 días y en la zona Sur los 28 días. Situaciones puntuales, como la vacante en la agencia de Chañaral que permaneció abierta por más de tres años pese a los incentivos ofrecidos, evidencian que el modelo de reclutamiento actual ha alcanzado un límite de ineficiencia frente a la complejidad geográfica y generacional. Estos retrasos no son meramente estadísticos, sino que representan una incapacidad operativa para cubrir posiciones de salud de manera oportuna.

Identificación del Problema y su Origen

El problema se define como una brecha de eficiencia en la captación de talento médico, derivada del desconocimiento de los motivadores y factores de decisión de las nuevas generaciones de profesionales. Los elementos de origen identificados son:

• Desconocimiento del Perfil Psicográfico: Existe una carencia de información cualitativa sobre los factores no monetarios (calidad de vida, bienestar familiar, desarrollo técnico) que este segmento prioriza al tomar decisiones laborales.

• Propuesta de Valor Genérica: El paquete de beneficios se comunica mediante documentos extensos que no resaltan los incentivos específicos requeridos para la práctica médica en zonas críticas.

• Ineficiencia de Canales: La dependencia de LinkedIn (donde se destina el 50% del presupuesto de búsqueda) y ferias tradicionales presenta resultados nulos para este perfil especializado, donde solo el 8% de las contrataciones exitosas provienen de referidos internos.

• Desventaja Competitiva: La organización pierde atractivo frente al sector público, que ofrece "asignaciones de zona" que superan la oferta líquida de la mutual, y frente al sector privado que ofrece mayor comodidad urbana.

Consecuencias e Impacto Organizacional (Alcances)

La persistencia de este déficit de captación impacta directamente la sostenibilidad y el propósito de la red de salud:

• Impacto Financiero: Al superar los plazos permitidos, la ACHS debe recurrir a consultoras externas (Head Hunters) que exigen comisiones del 13% de la renta bruta anual del candidato, además de generar sobrecostos en horas-hombre de los equipos de Marca Empleadora y Marketing.

• Desgaste Operativo y Reputacional: La falta de cobertura médica sobrecarga a los Business Partners (BP) y equipos de operaciones, afectando la calidad del servicio percibida por los afiliados y poniendo en riesgo el compromiso institucional de brindar cuidado integral en puntos críticos del país.

Expectativas de la Organización

La ACHS espera transitar de un modelo de "reacción al dolor" hacia una toma de decisiones basada en evidencia. Se busca un levantamiento fidedigno del perfil médico ideal para rediseñar la Marca Empleadora y proponer beneficios eficientes que aseguren la continuidad operativa en regiones. Al solucionar este problema, la organización pretende optimizar el uso de sus recursos, reducir la dependencia de terceros y garantizar la dotación necesaria para cumplir fielmente con su propósito social de cuidado.

Análisis del problema a partir del marco teórico

Se identifica y analiza el problema y sus elementos, utilizando conceptos teóricos del subsistema de gestión de personas y del problema. Se incorpora evidencia empírica del subsistema de gestión de personas y del problema.

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cuál es el problema y cuáles son los elementos que le dan origen?
2. ¿Qué conceptos teóricos de GDP son necesarios para entender y abordar el problema desde una mirada de GDP?
3. ¿Hay modelos, en la literatura relacionada a GDP, desde donde podamos ver el problema? Debe ser de acuerdo al contexto de la organización: es una fundación, produce bienes, ofrece servicios, etc. ¿Qué dice la evidencia empírica al respecto?
4. ¿Qué hipótesis o variables clave se pueden desprender del análisis anterior? Estas deben establecer el vínculo entre el problema de la organización (dimensión práctica) y el marco teórico desde el que se aborda (dimensión teórica)

d) Análisis del problema a partir del Marco teórico:

Identificación del problema y sus orígenes

El problema central radica en una brecha de eficiencia en la captación y selección de talento médico para agencias rurales y zonas extremas de la Achs, lo que se traduce en un incumplimiento crítico de los *tiempos de cobertura de vacantes* (time-to-fill). Esta problemática no es aislada; datos del Ministerio de Salud (MINSAL, 2022) indican que en Chile existe una brecha histórica en la distribución médica, donde las zonas extremas enfrentan un déficit de especialistas superior al 40% en comparación con la Región Metropolitana.

En este contexto de escasez, los orígenes del problema en la Achs se explican por:

a. **Desconocimiento psicográfico:**

Según Snell y Morris (2019), el reclutamiento estratégico exige analizar las características demográficas y motivacionales del mercado laboral. La Achs carece de datos actualizados sobre qué factores no monetarios (calidad de vida, bienestar familiar) movilizan a las nuevas generaciones de médicos.

b. **Propuesta de valor al empleado genérica:**

La organización utiliza un paquete de beneficios estandarizado que no resalta incentivos específicos para el esfuerzo que implica el traslado a zonas críticas, lo que disminuye su tasa de rendimiento en la atracción de candidatos viables.

c. **Ineficiencia en canales de reclutamiento:**

Dependencia de medios tradicionales y masivos que, como señalan Snell y Morris (2019), suelen tener un bajo retorno de inversión (ROI) cuando se buscan perfiles técnicos altamente especializados o escasos.

d. **Desventaja competitiva estructural:**

Dificultad para competir financieramente frente a la "asignación de zona" (bonos que pueden llegar hasta el 100% del sueldo base) que ofrece el sector público en regiones extremas (Ley 19.336).

2. Conceptos teóricos de gestión de personas (GDP)

Para abordar este desafío y proponer soluciones estructurales, el análisis se sustenta en la literatura del subsistema de Reclutamiento y Selección, empleando los siguientes conceptos clave:

a. **Reclutamiento estratégico y marca empleadora (Employer branding):**

Snell y Bohlander (2013) definen el reclutamiento no solo como la búsqueda de candidatos, sino como una herramienta de marketing donde la organización promociona por qué es un lugar deseable para trabajar. Cuando una empresa no puede competir únicamente por salario, su marca empleadora y reputación social (proteger a los trabajadores, en el caso de la Achs) se vuelven su principal activo de atracción.

b. Propuesta de valor al empleado (EVP):

Corresponde a la suma total de reconocimientos y recompensas que la empresa ofrece (Ulrich & Brockbank, 2007). Para ser efectiva en mercados restrictivos (como el rubro médico rural), la EVP debe estar alineada con las expectativas únicas del talento que se desea atraer, diferenciándose claramente de los competidores directos (sector público y clínicas privadas). Si no se emplea adecuadamente, esto se transforma en poca competitividad frente a incentivos del sector público.

c. Sistema de recompensas y salario emocional::

De acuerdo con el modelo de recompensas de Snell y Morris (2019), la compensación debe dividirse en componentes extrínsecos (salario, bonos) e intrínsecos (reconocimiento, equilibrio trabajo-familia, oportunidades de desarrollo continuo). El salario emocional busca potenciar estos últimos elementos intrínsecos para generar retención y compromiso a largo plazo.

3. Modelo teórico y evidencia empírica.

3.1 Definición y relevancia del modelo: El modelo teórico que se considera más cercano a la problemática actual de la Achs, es el "Modelo de Reclutamiento Estratégico" propuesto por Snell y Morris (2020). A diferencia del reclutamiento tradicional, este modelo plantea que la búsqueda de talento es un proceso proactivo que debe estar amarrado a la estrategia de la organización y sus objetivos.

Según el ***Anexo 1***, el modelo se divide en 6 etapas clave, las cuales se explicaran y relacionarán con la Achs a continuación:

a. Marca: Representa la identidad de la organización como empleador.
   - En la Achs: Aunque la marca se apoya en un propósito de cuidado, la evidencia muestra que no logra competir con los incentivos financieros del sector público (bono por zona). El hecho de tener vacantes críticas por más de 3 años en agencias como Chañaral demuestra que la marca no está siendo algo atractivo para el talento en regiones.
b. Enfoque: Define la segmentación necesaria del talento para el negocio.
   - En la Achs: El foco está en médicos para zonas fuera de la Región Metropolitana. El problema es que el enfoque de comunicación es genérico, utilizando una EVP estándar y documentos de 40 páginas que no resaltan los beneficios específicos que este perfil necesita y valora.
c. Ubicación: Se refiere a la decisión estratégica de los canales de búsqueda y el lugar donde se necesita el talento.
   - En la Achs: Hay una desacierto en la elección de canales, ya que se destina un 50% del presupuesto a LinkedIn y no genera reclutamiento efectivo. La ubicación de búsqueda no coincide con los espacios donde se encuentra el talento médico rural.
d. Técnica: Se refiere a los métodos y herramientas para atraer al candidato.

- En la Achs: La técnica actual es ineficiente. Esto obliga a acudir a HeadHunters que cobran una comisión del 13% por candidato.

e. Oportunidad: Define si la necesidad es inmediata o futura.
   - En la Achs: El hecho de que el tiempo de respuesta sea de 56 días en el norte, superando los 24 días, puede darnos indicio de que la organización está buscando talento por urgencia y no por oportunidad estratégica.

f. Decisión: Define quien es el responsable en tomar la decisión en procesos de reclutamiento.
   - En la Achs: Se cuenta con un equipo específico. Sin embargo, la ineficiencia del proceso actual, obliga a derivar la decisión a terceros (HeadHunters) para resolver la incapacidad operativa de cerrar vacantes.

3.2 ¿Por qué elegimos este modelo?

La razón es que nos permite pasar de la queja "no hay médicos" a un análisis de gestión real. Nos da la base teórica para demostrar que la solución no es solo de salario, sino arreglar la EVP y optimizar los canales para dejar de depender de HeadHunters que hoy se llevan un 13% de comision, y lo mas importante, tener un equipo de médicos en todos los recintos.

3.3 Evidencia empírica: Los datos nos demuestran la real crisis. El tiempo de respuesta de hasta 56 días hábiles en el norte (más del doble del estándar de 24 días), más las vacantes que llevan 3 años sin llenarse, nos confirman que el modelo actual ya no da para más. No se está logrando conectar con la realidad de escasez de especialistas en regiones.

4. Hipótesis y variables claves.

4.1 Hipótesis

A partir del vínculo entre la dimensión práctica del problema y la teoría de GDP, planteamos las siguientes hipótesis para guiar la consultoría:

a. Si se personaliza la EVP con enfoque en un médico rural con motivadores no monetarios y bienestar en cambio de un pdf de 40 páginas, esto con el fin de reducir significativamente los tiempos de vacancia.
b. Si se optimiza el mix de fuentes de reclutamiento, priorizando redes de referidos y canales específicos de salud sobre portales masivos, los costos de selección y la dependencia de consultoras externas deberían disminuir, tal como sugiere la literatura sobre la eficiencia en la atracción de talento (Dessler, 2020)

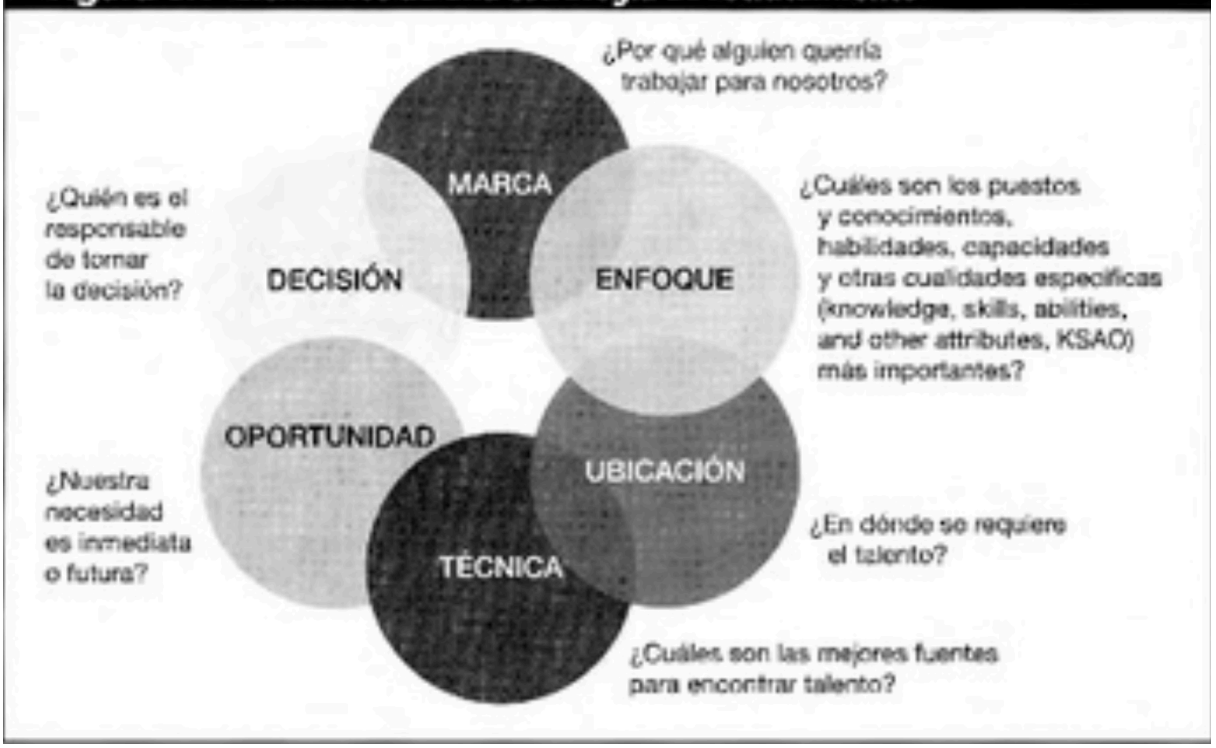
4.2 Variables claves

- **Variable independiente:** Claridad de la Marca empleadora y selección estratégica de las fuentes de reclutamiento.
- **Variable dependiente:** Eficiencia en la dotación, medida a través del cumplimiento del SLA (tiempos de respuesta) y la reducción de costos operativos de contratación.
- **Variable mediadora:** Nivel de atractividad de la oferta frente a los incentivos del Estado y las clínicas privadas.

Bibliografía

1. Caracterización de las especialidades médicas en Chile en 2022. (2023). En *superdesalud.gob.c* (N.º 26547). Recuperado 13 de abril de 2026, de https://www.superdesalud.gob.cl/app/uploads/2024/02/articles-26547_recurso_1.pdf
2. Snell, S. A., & Morris, S. S. (2019). *Administración de recursos humanos*. Cengage Learning.
3. Snell, S. A., & Bohlander, G. W. (2013). *Administración de recursos humanos* (16.ª ed.). Cengage Learning.
4. Ulrich, D., & Brockbank, W. (2007). *La propuesta de valor de recursos humanos*. Ediciones Deusto.
5. Alles, M. A. (2016). *Dirección estratégica de recursos humanos: Gestión por competencias* (3.ª ed.). Granica.
6. Chiavenato, I. (2020). *Gestión del talento humano: El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones* (5.ª ed.). McGraw-Hill.
7. Dessler, G. (2020). *Administración de recursos humanos* (15.ª ed.). Pearson Educación.
8. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Comportamiento organizacional* (17.ª ed.). Pearson Educación.

Figura 5.1 Elementos de una estrategia de reclutamiento



Anexo 1